

A M C de Psychiatrie 2020-2021

Memento pour les présentations cliniques

Motif et origine de la consultation / hospitalisation :

Anamnèse actuelle et résumé des problèmes :

Anamnèse familiale

Anamnèse personnelle :

Scolarité / formation :

Antécédents psychiatriques familiaux et personnels :

Antécédents somatiques :

Habitudes : tabac, alcool, drogues et autres

Médicaments :

Examen psychiatrique (status mental) :

Diagnostic différentiel :

Projet de prise en soins / traitement :

Interprofessionnalité :

Précisez :

- qui intervient dans la prise en soin du patient

Fonction spécifique nature du suivi de l'intervenant (infirmier, psychologue, assistants sociaux, psychomotriciens, ergothérapeutes, diététiciennes, etc.)

- quel autre membre de l'équipe participe au suivi.

Pour chaque catégorie professionnelle indiquez quel rôle spécifique, quelles responsabilités sont assumées par chaque intervenant et comment ils communiquent entre eux

Sémiologie

Mémento pour les étudiants

EXAMEN PSYCHIATRIQUE GENERAL (STATUS MENTAL)

Lors de l'examen psychiatrique (status mental) pensez à demander au patient ou évaluez :

- s'il est orienté dans le temps
- s'il est orienté dans l'espace
- s'il a des troubles de la mémoire
- s'il présente des symptômes d'anxiété, de tension interne, d'agitation
- si sa pensée est délirante
- s'il présente des hallucinations
- quelle est sa thymie
- s'il a des troubles du sommeil
- s'il a des troubles de l'appétit
- s'il présente des idées suicidaires
- s'il est conscient d'être malade
- s'il prend des médicaments
- s'il prend d'autres substances

ANAMNESE

Dans l'anamnèse, pensez à questionner le patient sur :

- sa scolarité
- son activité professionnelle
- son contexte familial
- son contexte affectif actuel
- son contexte social actuel (amis, connaissances, hobbies, etc.)
- ses antécédents psychiatriques
- ses antécédents médicaux (somatiques)

COMMUNICATION ET ATTITUDES RELATIONNELLES

Lors de l'entretien, pensez à :

- accueillir le patient de façon adéquate (en vous présentant, nom, prénom, fonction) ;
- commencer la discussion par une première question ouverte ;
- utiliser un langage clair et sans jargon médical ;
- vous montrer attentif à la personne ;
- vous intéresser au contexte socioculturel du patient (sa représentation du trouble, ses croyances, sa culture familiale ou d'appartenance : p. ex quelle est la compréhension de ses difficultés/symptômes/maladie (p ex. vulnérabilité/fragilité personnelles, stress lié au contexte, attribution externe et/ou projection des causes, non reconnaissance de la problématique/anosognosie, autres références culturelles, etc)

A la fin de l'entretien :

- donnez un diagnostic de présomption en termes compréhensibles ;
- informez le patient de la suite à donner (*besoins d'investigations, d'un traitement, etc.*) en termes compréhensibles ;
- demandez au patient s'il a une question à poser ou un autre problème dont il voudrait parler.